

氟西汀的药物相互作用 (综述)

陈福新

综述氟西汀与其他药物的相互作用如下。

1 与三环抗抑郁剂 (TCA) 的相互作用^[1~4]

氟西汀与 TCA 的相互作用是通过两种渠道: ①通过抑制细胞色素 P450 IID₆ 的催化作用, 影响 TCA 的代谢, 使其血浓度增高; ② Baron 等 (1988) 通过动物试验发现氟西汀和去甲丙咪嗪 (每日剂量 50mg/kg) 联用时皮层 β 受体的向下调节 (抗抑郁作用的公认标志) 出现得更快, 范围更广, 说明合用可调低 β 受体的敏感性。

Nelson 等 (1991) 给 14 例病人联用去甲丙咪嗪和氟西汀, 结果发现, 联合用药者比单用去甲丙咪嗪起效快, 作用强; 系统测定血药水平发现, 联合用药者虽用药剂量小, 但去甲丙咪嗪血浆水平高。Seth 等 (1992) 报道 8 例顽固性抑郁症患者联用氟西汀和去甲替林治疗后获得成功。有研究显示, 对 25 例难治性抑郁症单用氟西汀治疗 4 周无效的病人, 合用环类药后可获较好疗效。

氟西汀能使 TCA 的血浆水平增加 2~10 倍, 且停药后作用还能持续几个星期, 在氟西汀换成 TCA 或两者合用时, 有 TCA 中毒的危险。王家宝等报告 1 例合用氟西汀 20mg/d, 阿米替林 150mg/d, 10 天后出现意识模糊, 定向障碍, 有大量幻听, 躁动不安, 大汗淋漓, 四肢粗大震颤, 面色发青, 心率 150 次/分, 白细胞升高, 停用后好转, 再用又发生。

2 与碳酸锂的相互作用^[5~6]

有资料显示, 氟西汀与锂盐合用治疗重度抑郁、分裂情感性抑郁、强迫观念、伴食欲亢进性抑郁均获成功, 且无严重不良反应。Fava (1994) 将 41 例经氟西汀每日 20mg 治疗 8 周无效的患者, 随机分为 3 组, 第一组只用氟西汀 40mg/d, 第二组用氟西汀 20mg/d 及去甲丙咪嗪 25~50mg/d, 第三组为氟西汀 20mg/d 及锂盐 300~600mg/d。结果发现, 氟西汀与低剂

量锂盐合用可使无效者获得相当的疗效。

两药合用可能改变锂在脑组织的分布, 提高了锂在红细胞与血浆浓度的比例, 也可能改变了受体的敏感性, 会出现严重的锂中毒反应。Salama (1989) 报告 1 例 44 岁女性, 服锂盐 20 年, 一直没有问题, 当出现抑郁症状时加用氟西汀, 几天后出现头昏, 站立不稳, 手臂僵直, 腿僵直, 步态不稳以及言语障碍, 测血锂浓度为 1.79mEq/L。

3 与抗精神病药物的相互作用^[5,7,8]

对伴有精神病性症状的重性抑郁, 氟西汀与奋乃静合用有效, 合用效果与 TCA 加抗精神病药相似, 并且氟西汀副反应少, 病人更易接受。氟西汀有抑制细胞色素 P450 IID₆ 的催化代谢作用, 与抗精神病药联用会干扰后者的代谢, 影响抗精神病药的清除率和半衰期, 使药物血浓度升高。因此, 合用时需适当减少剂量, 注意药物的相互作用。

4 与 MAOI 的相互作用

已有数例氟西汀与 MAOI 合用的病人出现致命副反应的报道。因此, 当氟西汀治疗无效的病人改用 MAOI 时, 至少需要停服氟西汀 5 周以上, 以保证该药及其代谢产物的完全排泄, 避免联合使用。

5 与丁螺环酮的相互作用^[5,9]

Joffe (1993) 报告 25 例难治性抑郁患者经丁螺环酮与氟西汀联用, 其中 17 例好转且未见明显不良反应。前者对后者的增效作用可能是提高了中枢神经系统的 5-HT 能的功能。临床运用时应注意出现精神症状及癫痫发作。

6 与 L-色氨酸的相互作用^[10]

氟西汀与 L-色氨酸合用时可出现危险的 5-羟色胺能综合征, 其临床表现为兴奋, 大汗, 僵硬, 高热, 反射亢进, 心动过速, 低血压, 昏

迷甚至死亡,故两者不宜联用。机理为氟西汀作用于突触前膜,抑制 5-HT 再摄取,L-色氨酸是 5-HT 的前体,两者合用加强了 5-HT 能活性。

7 与巴比妥类的相互作用

巴比妥类具有酶诱导作用,加强氟西汀的代谢而降低血药浓度;氟西汀抑制细胞色素 P450 的催化代谢,可延长巴比妥类半衰期,故两药合用,应注意巴比妥的毒性和氟西汀的抗抑郁效果。

8 与苯妥英的相互作用^[3]

氟西汀竞争抑制细胞色素 P450,而苯妥英由 P450 2C₉ 代谢,因此可影响苯妥英的血药浓度。26 例病人在氟西汀开始治疗后,其苯妥英稳态血浓度可明显升高至中毒水平。故两者合用时宜减少苯妥英剂量。

9 与卡马西平的相互作用^[10,11]

氟西汀可以通过竞争性抑制肝内代谢过程而与卡马西平产生协同交互作用,合用将导致血药浓度增加和药物副反应明显化。有资料报告,对维持治疗病人及健康自愿者给予氟西汀加卡马西平时,卡马西平血浓度增高,故联用时应进行密切临床观察。

10 与苯二氮 类的相互作用^[12]

氟西汀可影响细胞色素 P450 各亚型酶,而 P450 是苯二氮 类氧化代谢中重要的肝脏同功酶,合用时可使苯二氮 类的代谢受阻,血药水平升高。

11 与 β 受体阻滞剂的相互作用

两者合用时没有明显的药物相互作用,但普萘洛尔(心得安)和 metoprolol 在肝脏内代谢,氟西汀可抑制这些药物的代谢,合用时需适当降低剂量。

12 与华法令、地高辛的相互作用

氟西汀与血清蛋白结合率高达 95%,当与蛋白结合药物华法令、地高辛等合用时,由于竞争结合能将华法令、地高辛置换出蛋白结合部位,影响它们的药代动力学。华法令也由细胞色素 P450 2C 代谢,氟西汀能抑制该酶,出现凝血酶原时间增加,故联用时应严密观察。

13 与酒精的相互作用

饮酒可引起肝功能改变而影响药物的代谢,在服药期间应尽可能禁酒或减少酒精量。

参 考 文 献

- 1 李红政,雷美英. SSRI 与 TCA 联用的相互作用和治疗应用. 国外医学精神病学分册, 1996, 23: 171-173.
- 2 钱敏才,陈加美. SSRI 联用 TCA 的疗效与副反应. 临床精神医学杂志, 1997, 7: 111-112.
- 3 谢维爵摘译. 氟西汀合并环类抗抑郁药治疗难治性抑郁症. 国外医学精神病学分册, 1996, 23: 237.
- 4 王家宝,张凤玉. 精神药物副反应及其处理(抗抑郁剂). 临床精神医学杂志, 1998, 8: 187.
- 5 李焕德,李革晖. 抗抑郁新药及抑郁症药物治疗的进展. 国外医学精神病学分册, 1996, 23: 76-79.
- 6 Fava M, Rosenbaum JF, McGrath PT, et al. Lithium and tricyclic augmentation of fluoxetine treatment for resistant major depression: A double-blind, controlled study. Am J Psychiatry, 1994, 151: 1372-1374.
- 7 程文红. 盐酸氟西汀. 上海精神医学, 1995, 新 7: 117-122.
- 8 颜文伟. 新一代抗抑郁药. 上海精神医学, 1997, 新 9: 304-307.
- 9 Joffe RT, Schuller DR. An open study of buspirone augmentation of serotonin reuptake inhibitors in refractory depression. J Clin Psychiatry, 1993, 54: 269-271.
- 10 王继军,王祖承. 氟西汀(百忧解)的临床应用. 国外医学精神病学分册, 1995, 22: 193-201.
- 11 袁浩龙. 新型抗抑郁药与细胞色素 P450 系统. 国外医学精神病学分册, 1997, 24: 39-43.
- 12 朱双罗. 老年人精神药物疗法的新进展. 国外医学精神病学分册, 1995, 22: 160-165.

(收稿: 1998-09-04)

会 讯

江苏省第六次精神病学学术会议于 1998 年 9 月 22~26 日在淮阴市召开。到会代表 70 余人,收到论文 73 篇,其中大会交流 22 篇,主要侧重于情感性精神障碍的亚型,生物学,社会心理学,治疗,转归等方面的研究,论文质量普遍较高。会议邀请了三位专家作专题报告。本次会议选举了新一届专科学会委员会,确定下次会议在 2000 年召开,主题为情感性精神障碍,并申报 1999 年继续教育项目:会诊-联络精神病学。(陈建国)